

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **Estrategia de Salud Familiar y Promoción de la Salud** es el **núcleo operativo** del actual sistema de salud chileno y constituye la **expresión práctica del Modelo de Atención Integral (MAIS)** en la Atención Primaria.

Su propósito es **trascender el modelo biomédico** centrado en la enfermedad, reemplazándolo por un enfoque integral, preventivo y comunitario, donde **la familia y la comunidad son los ejes del cuidado y la gestión sanitaria**.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es de alta relevancia porque sintetiza competencias clínicas, preventivas, comunicacionales y de gestión social del médico general, especialmente en **APS y contextos territoriales vulnerables**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición

“La Estrategia de Salud Familiar es una forma de organizar los servicios de salud que ubica a la familia y la comunidad como unidad central de intervención, buscando el bienestar integral, la equidad y la participación activa de las personas en su proceso de salud.”

(MINSAL, 2013 – Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria)

La estrategia articula **promoción, prevención, atención, rehabilitación y participación social** como componentes interdependientes del proceso sanitario.

2.2. Fundamentos teóricos

La estrategia se basa en tres pilares conceptuales:

1. **Enfoque biopsicosocial:** considera factores biológicos, psicológicos y sociales en el proceso salud-enfermedad.
2. **Determinantes sociales de la salud:** condiciones estructurales que influyen en el bienestar (educación, vivienda, trabajo, género).

3. **Ciclo vital y enfoque de riesgo:** identifica grupos prioritarios según etapa de vida y vulnerabilidad.

2.3. Principios orientadores

Principio	Descripción
Integralidad	Aborda promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.
Equidad	Prioriza a poblaciones vulnerables y territorios con mayor brecha sanitaria.
Continuidad del cuidado	Acompaña al usuario durante todo su ciclo vital.
Participación social	Reconoce el derecho de la comunidad a incidir en la gestión local.
Intersectorialidad	Coordina acciones con educación, vivienda, trabajo y municipio.
Enfoque familiar y comunitario	La familia y la comunidad son los ejes del proceso de atención.

3. Marco normativo y político

La Estrategia de Salud Familiar se sustenta en:

- **Ley N° 19.937 de Autoridad Sanitaria (2004).**
- **Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MINSAL, 2013).**
- **Política Nacional de Promoción de la Salud (MINSAL, 2018).**

- **Política Nacional de Salud 2021–2030.**
 - **Objetivos Sanitarios 2021–2030.**
 - **Estrategia Municipios, Comunas y Comunidades Saludables (MINSAL–SUBDERE).**
-

4. Estructura y componentes de la Estrategia de Salud Familiar

La estrategia se implementa principalmente en los **CESFAM** (Centros de Salud Familiar) y sus extensiones territoriales (CECOSF y postas rurales).

Componentes principales:

1. **Cuidado centrado en la persona y su familia.**
 2. **Abordaje integral según ciclo vital.**
 3. **Gestión del riesgo y de casos.**
 4. **Participación social y comunitaria.**
 5. **Intersectorialidad.**
 6. **Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.**
 7. **Continuidad del cuidado.**
-

5. Enfoque familiar

5.1. Concepto

La familia es considerada la **unidad básica de salud y enfermedad**, donde las condiciones físicas, emocionales, económicas y culturales determinan el bienestar de sus miembros.

5.2. Herramientas utilizadas en APS

Herramienta	Objetivo	Aplicación
Ficha familiar	Identificar estructura, riesgos y recursos familiares.	Registro base en APS.
Genograma	Representar relaciones y antecedentes familiares.	Detección de patrones hereditarios o dinámicas familiares.
Ecomapa	Visualizar redes de apoyo y entorno comunitario.	Intervenciones sociales y psicosociales.
Entrevista familiar	Explorar dinámicas, roles y comunicación.	Plan terapéutico familiar.

5.3. Clasificación de familias según riesgo

Nivel de riesgo	Características	Intervención
Bajo	Estructura y funcionalidad protectora.	Mantención y promoción.
Medio	Tensiones o conflictos temporales.	Intervención educativa y apoyo psicosocial.
Alto	Violencia, negligencia, consumo, pobreza extrema.	Intervención intensiva y coordinación intersectorial.

6. Enfoque comunitario y territorial

6.1. Concepto

“La comunidad es el conjunto de personas que comparten un territorio, vínculos sociales y responsabilidades colectivas sobre su salud.” (OPS/OMS, 2010)

6.2. Objetivos

- Promover el empoderamiento ciudadano en salud.
- Identificar y priorizar problemas locales.
- Fomentar redes de apoyo y corresponsabilidad.

6.3. Herramientas de trabajo comunitario

1. Diagnóstico participativo local de salud.
2. Plan comunal de promoción de la salud.
3. Consejo de Desarrollo Local (CDL).
4. Ferias y actividades de educación en salud.
5. Mesas intersectoriales de promoción.

6.4. Enfoque territorial

Cada CESFAM gestiona un **territorio de responsabilidad sanitaria**, definido geográficamente, que permite planificar intervenciones focalizadas y equitativas.

7. Promoción de la salud

7.1. Definición

“Proceso que permite a las personas y comunidades incrementar el control sobre los determinantes de su salud y mejorarla.”

(Carta de Ottawa, OMS 1986)

7.2. Principios de la promoción de la salud

1. Empoderamiento ciudadano.
2. Equidad y justicia social.
3. Participación activa.

- 4. **Intersectorialidad.**
 - 5. **Sostenibilidad.**
-

7.3. Estrategias de promoción en Chile

a) Estrategia de Municipios, Comunas y Comunidades Saludables

Iniciativa MINSAL–SUBDERE que articula acciones con los municipios, fomentando políticas locales saludables (espacios activos, alimentación saludable, participación).

b) Estrategia de Promoción Escolar

Programas como **Vida Sana Escolar** y **Escuelas Saludables**, que promueven hábitos saludables desde la infancia.

c) Estrategia de Espacios Amigables

Dirigida a adolescentes, promueve atención confidencial y libre de estigma.

d) Campañas nacionales

- **Elige Vivir Sano.**
 - **Plan Nacional contra la Obesidad Infantil.**
 - **Estrategia Nacional de Salud Mental Comunitaria.**
-

8. Niveles de prevención en la estrategia familiar

Nivel de prevención	Objetivo	Ejemplo en APS
Primaria	Evitar aparición de enfermedad.	Promoción de lactancia, vacunación, talleres comunitarios.
Secundaria	Detección precoz.	PAP, EMPA, control cardiovascular.

Terciaria	Disminuir secuelas y rehabilitar.	Programa post-ACV, cuidados domiciliarios.
------------------	-----------------------------------	--

9. Intersectorialidad

La salud familiar requiere **acciones coordinadas entre sectores**:

Sector	Ejemplo de acción
Educación	Escuelas saludables, talleres de autocuidado.
Desarrollo social	Subsidios y programas de apoyo a familias vulnerables.
Trabajo	Programas de salud laboral y prevención de riesgos.
Municipio	Promoción de actividad física, ferias de salud.

La **Mesa Intersectorial de Promoción** y el **Plan Comunal de Salud** son los espacios de coordinación territorial formal.

10. Rol del médico general en la estrategia familiar y de promoción

1. **Liderar el equipo de salud familiar** (junto a enfermera, matrona, psicólogo, trabajador social).
2. **Evaluar integralmente a las personas y familias.**
3. **Aplicar herramientas familiares y comunitarias (genograma, ecomapa).**
4. **Realizar seguimiento longitudinal de casos.**

5. **Participar en diagnósticos participativos y planes comunales.**
6. **Educar y fomentar autocuidado en la comunidad.**
7. **Coordinar acciones intersectoriales y referir casos sociales.**

El médico general es **más que un clínico**: es **agente de cambio, educador y gestor territorial**.

11. Evaluación de la estrategia

El MINSAL evalúa la implementación de la Estrategia de Salud Familiar mediante indicadores de:

- Cobertura de controles preventivos.
 - Clasificación de familias por riesgo.
 - Porcentaje de población adscrita con ficha familiar actualizada.
 - Número de actividades comunitarias ejecutadas.
 - Participación en consejos de desarrollo local.
-

12. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Confundir salud familiar con atención domiciliaria	La salud familiar abarca diagnóstico, gestión y seguimiento familiar.
Pensar que la promoción es tarea exclusiva del municipio	Es responsabilidad compartida con el equipo de APS.

Limitar la promoción a campañas informativas

Implica empoderamiento y cambios estructurales.

Desconocer el rol intersectorial

Sin colaboración intersectorial, no hay promoción efectiva.

Pensar que la familia es solo un grupo conviviente

Se define por vínculos afectivos, no solo cohabitación.

Creer que los programas de promoción son complementarios

Son ejes estructurales del modelo integral.

13. Normativa y documentos ministeriales vigentes

- MINSAL (2013). Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria.
- MINSAL (2018). Manual de Estrategia de Promoción de la Salud.
- MINSAL (2021). Política Nacional de Salud 2021–2030.
- MINSAL/OPS (2022). Estrategia de Municipios, Comunas y Comunidades Saludables.
- Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (OMS, 1986).

14. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **Estrategia de Salud Familiar y Promoción de la Salud** es la base operativa del **Modelo Integral (MAIS)** y se centra en la familia, la comunidad y el territorio.
2. Integra **prevención, promoción, atención y rehabilitación**, con participación activa de la población.
3. La **promoción de salud** busca empoderar a las personas para modificar sus determinantes sociales.

4. La **intersectorialidad** y **participación comunitaria** son esenciales para la sostenibilidad.
5. El **médico general** lidera el cuidado integral, la coordinación territorial y la gestión familiar.
6. La **evaluación familiar y comunitaria** se realiza con herramientas estandarizadas (ficha familiar, genograma, ecomapa).
7. Este tema refleja el cambio paradigmático de la medicina chilena hacia un enfoque **integral, equitativo y centrado en las personas**, evaluado de forma transversal en el **EUNACOM**.